VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

Kwalitatief Onderzoek: probleemstelling, conceptueel kader en designs

Karijn Aussems

Met dank aan: Nicole Goedhart

Januari 2026

Afdeling Ethiek, Recht en Humaniora – Amsterdam UMC

Kritische theorie
Participatief actieonderzoek
Diverse (Kwalitatieve) onderzoeksmethodes

Fabel 9
Als we beginnen met de mensen die het wel kunnen, dan volgt de rest later
Lees meer op pag 32

Fabel 5
Mensen moeten gewoon een digitale vaardigheidstraining volgen
Lees meer op pag 20

Fabel 7
In Nederland heeft iedereen toegang tot internet
Lees meer op pag 28

DE Fabeltjes-krant

DECEMBER 2023

Elf fabels over digitale inclusie die kansenongelijkheid vergroten en een goede oplossing in de weg staan

We leven in een snel digitaliserende samenleving die de gezondheid en het welzijn van mensen beïnvloedt. De verhalen die we elkaar vertellen over de kansen van digitalisering spelen een belangrijke rol in hoe we met mensen omgaan, en hoe we (online) producten, dienstverlening en regelingen vormgeven. Als deze verhalen geen recht doen aan de complexe levens van mensen, dan kunnen ze bestaande kwetsbaarheden vergroten en het ontwikkelen van kansrijke oplossingen in de weg staan. Daarom delen we in deze krant de belangrijkste fabels over digitale in- en exclusie.

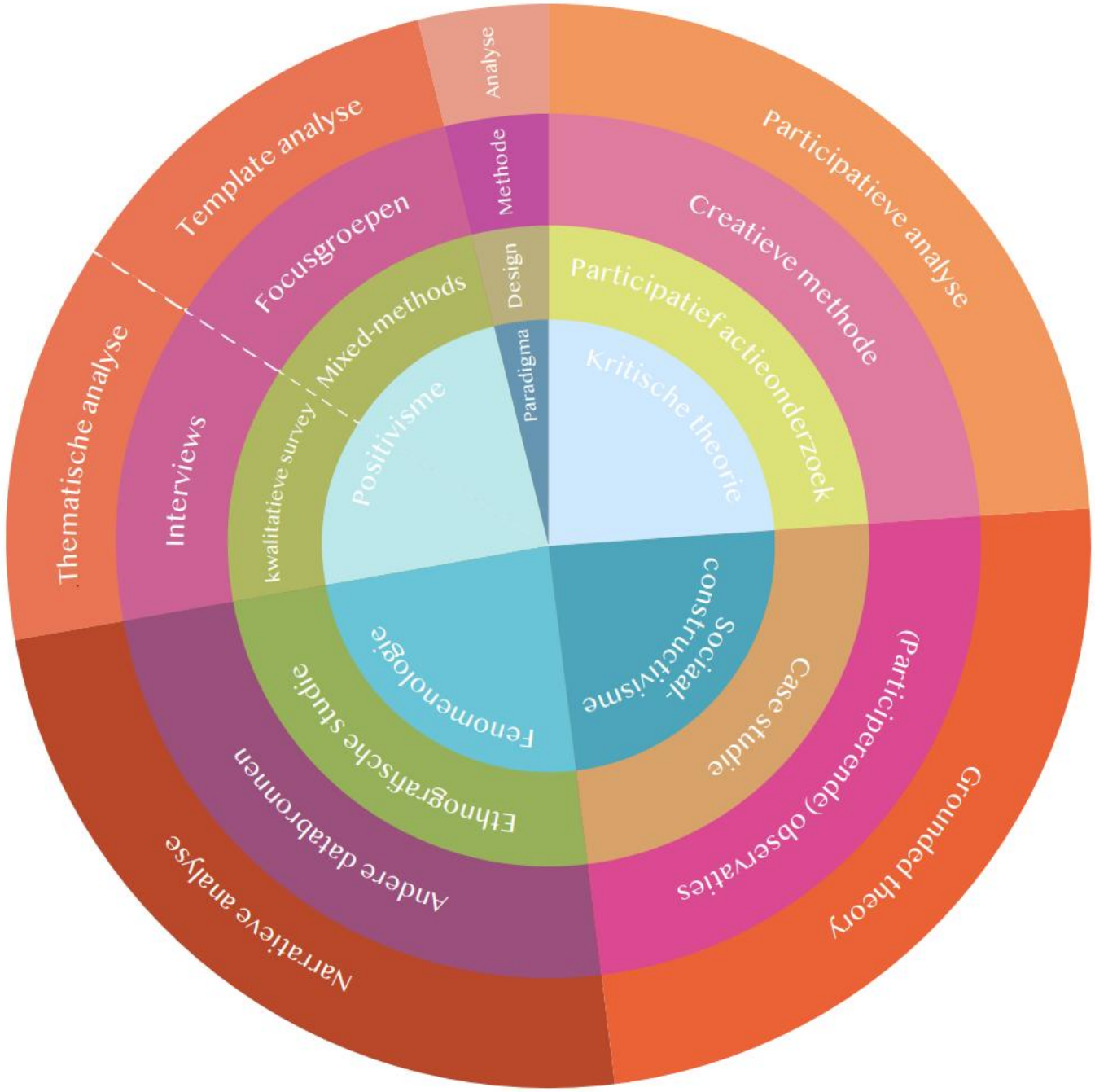
FABEL 2
Het probleem lost zich vanzelf op, over 20 jaar is die generatie dood
Lees meer op pag 12

FABEL 4
We willen wel wat doen, maar dan hebben we eerst goede cijfers nodig
lees meer op pag 18

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

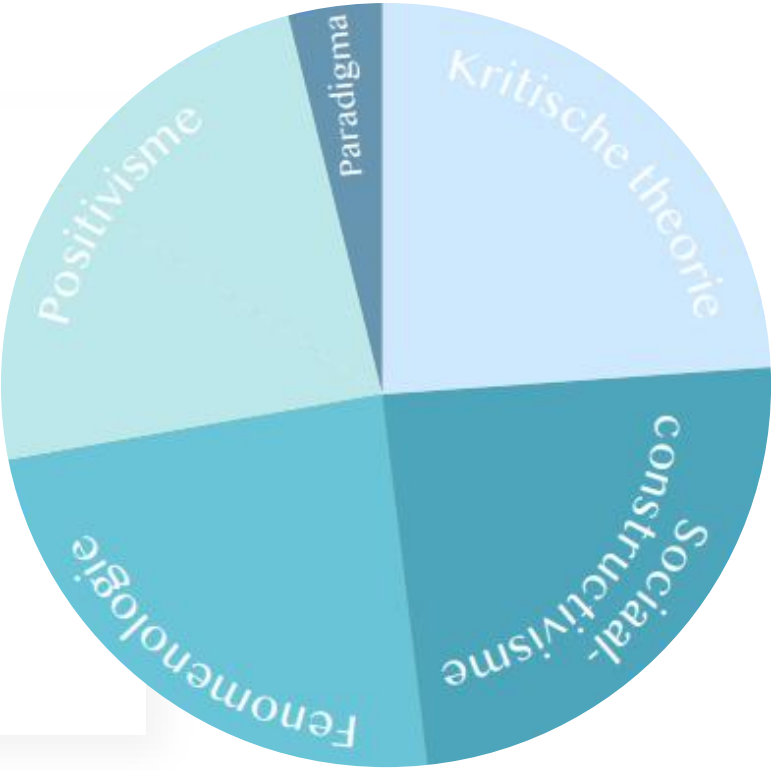
"Ik ben *maar een* mbo'er"

Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis


Thematische analyse
Template analyse
Analyse
Interviews
Focusgroepen
Methode
Narratieve analyse
Andere databronnen
Mixed-methods
kwalitatieve survey
Design
Ethnografische studie
Positivisme
Fenomenologie
Paradigma
Grounded theory
(Participerende) observaties
Participatief actieonderzoek
Case studie
Kritische theorie
Sociaal-constructivisme
Participatieve analyse
Creatieve methode

Recap hoorcollege 1 en 2

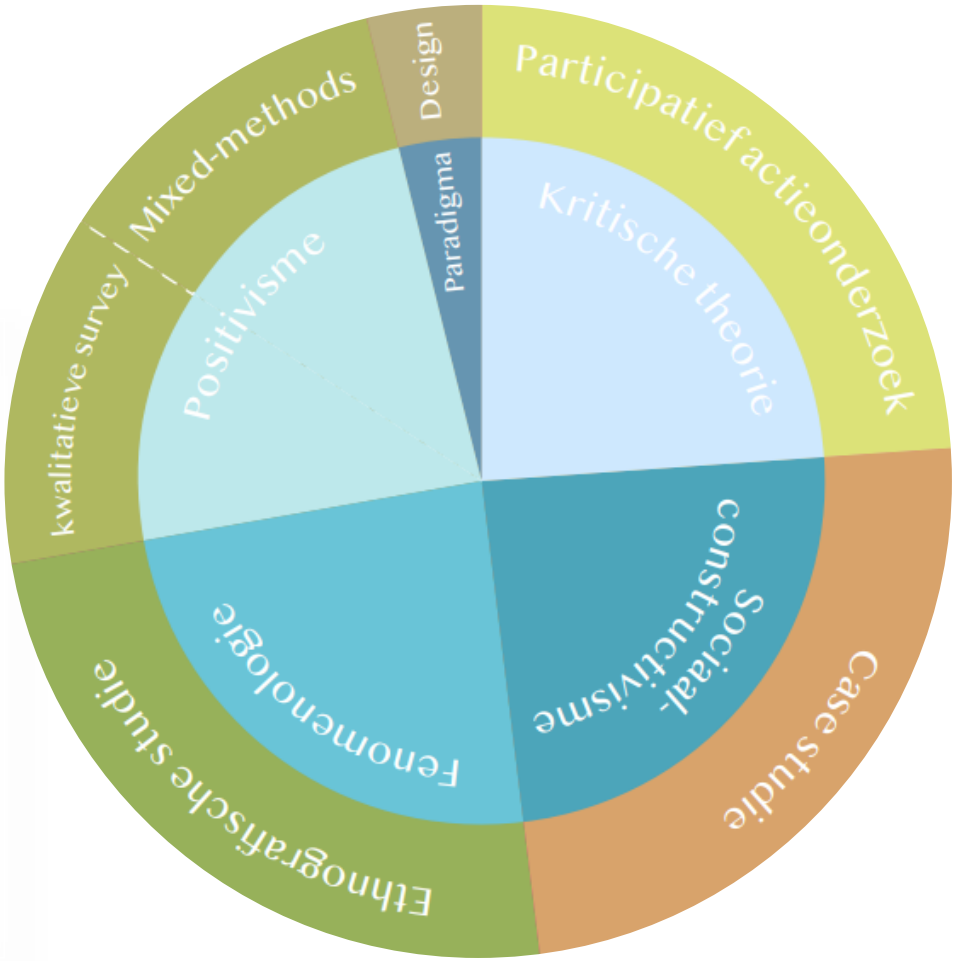
- Ontologie
- Paradigma



Doelen HC3

- Probleemformulering van een kwalitatief onderzoek en meest voorkomende onderzoeksdesigns kunnen herkennen en opstellen.

- Opstellen van een correcte onderzoeksvraag voor een kwalitatieve studie.



Probleemstelling

“De probleemstelling van een onderzoek is een tekst die de onderzoeker schrijft waarin het onderzoek waarvan hij later de resultaten zal presenteren aangekondigd en voorgesteld wordt. In artikelen is dit doorgaans de inleidende paragraaf.”

zie: hfdst. 4.1 Mortelmans

Probleemstelling

Situering van het onderzoeksdomein

Maatschappelijke en/of wetenschappelijke verantwoording

Het onderzoeksdoel

Onderzoeksvraag

Het conceptueel kader

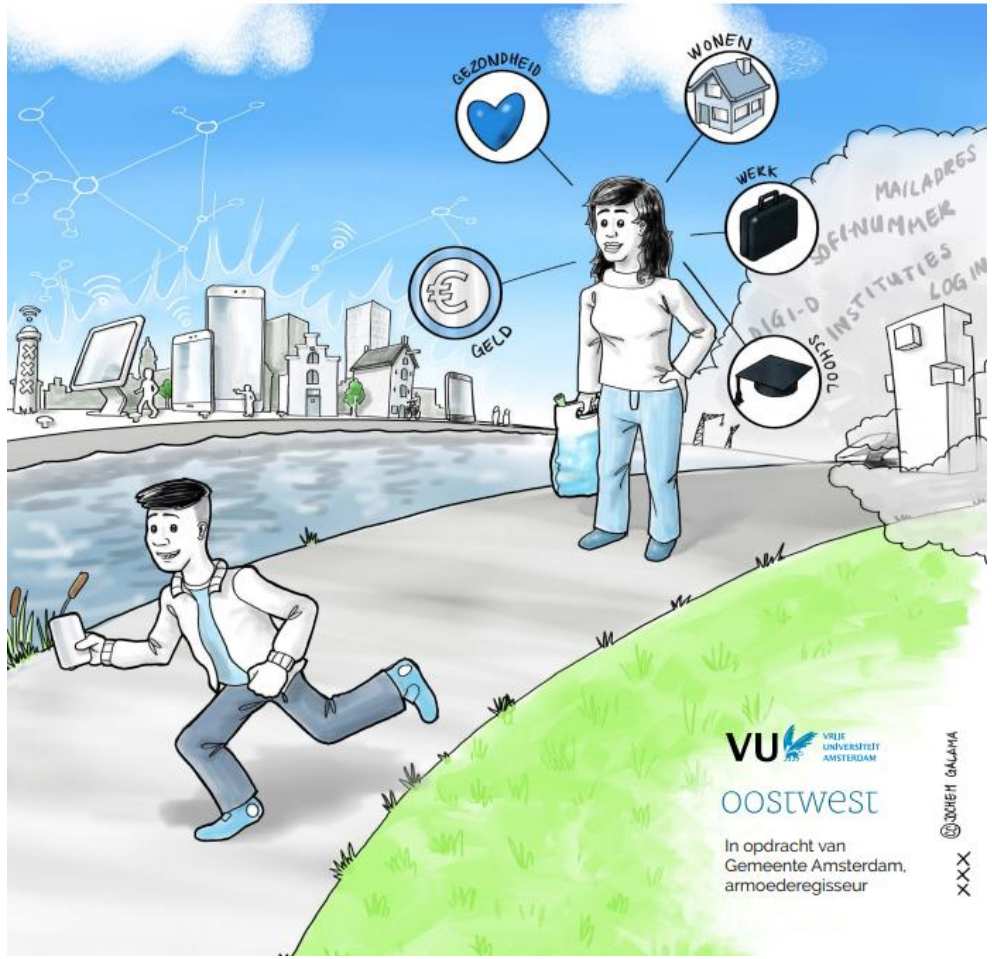
zie: hfdst. 4.2 Mortelmans

Een voorbeeld

Digitale ongelijkheid

Een participatieve verkenning in Amsterdam

Christine Dedding - Nicole Goedhart - Rolinka Kattouw



Onderzoeksdomein

Maart 2017: bijeenkomst Gemeente Amsterdam.

Maatschappelijke verantwoording

In het coalitieakkoord “Amsterdam is van iedereen 2014-2018” stelt het college dat alle Amsterdammers volwaardig mee moeten kunnen doen in de maatschappij ongeacht de dikte van hun portomonee. Uitgangspunt is kansengelijkheid. Amsterdam heeft een relatief hoof aantal kwetsbare huishoudens […] Het zijn juist deze kwetsbare jongeren en hun ouders die minder profiteren van de kansen die ICT te bieden heeft.

Wetenschappelijke verantwoording

In de wetenschappelijke literatuur is tot op heden vooral aandacht geweest voor welke burgers minder gebruik kunnen maken voor ICT dan anderen en de consequenties die dat heeft voor participatie in de maatschappij (Schreeder et al., 2017). Er is nog weinig aandacht geweest voor het feit dat ICT is ingebed in het dagelijks leven én hoe mensen daar zelf betekenis aan geven (Helsper, 2017)

Onderzoeksdoel

Exploratief
Verklarend
Beschrijvend
Emancipatorisch

zie: hfdst. 4.5 Mortelmans

Onderzoeksdoel:

Het doel van deze kwalitatieve en participatieve verkenning is om inzicht te geven in de belemmeringen die Amsterdamse minimagezinnen ervaren om volwaardig mee te doen in de digitale samenleving en daar gezamenlijk geschikte oplossingsrichtingen voor te ontwerpen.

Onderzoeksvraag

Hoe ervaren Amsterdams minima gezinnen de alsmaar digitaliserende wereld?

Wat zijn de barrières en faciliterende factoren voor volwaardige participatie in de steeds digitaal wordende wereld?

Hoe kan de digitale toegang voor gezinnen met een laag inkomen in Amsterdam effectief worden verbeterd?

Sensitizing concepts

Geven richting aan een kwalitatieve studie en maken de onderzoeker gevoelig voor bepaalde belangrijke concepten die bij de beantwoording van de vraag een rol kunnen spelen.

Onderzoeksvraag

Hoe ervaren Amsterdams minima gezinnen de alsmaar digitaliserende wereld?

Wat zijn de barrières en faciliterende factoren voor volwaardige participatie in de steeds digitaal wordende wereld?

Hoe kan de digitale toegang voor gezinnen met een laag inkomen in Amsterdam effectief worden verbeterd?

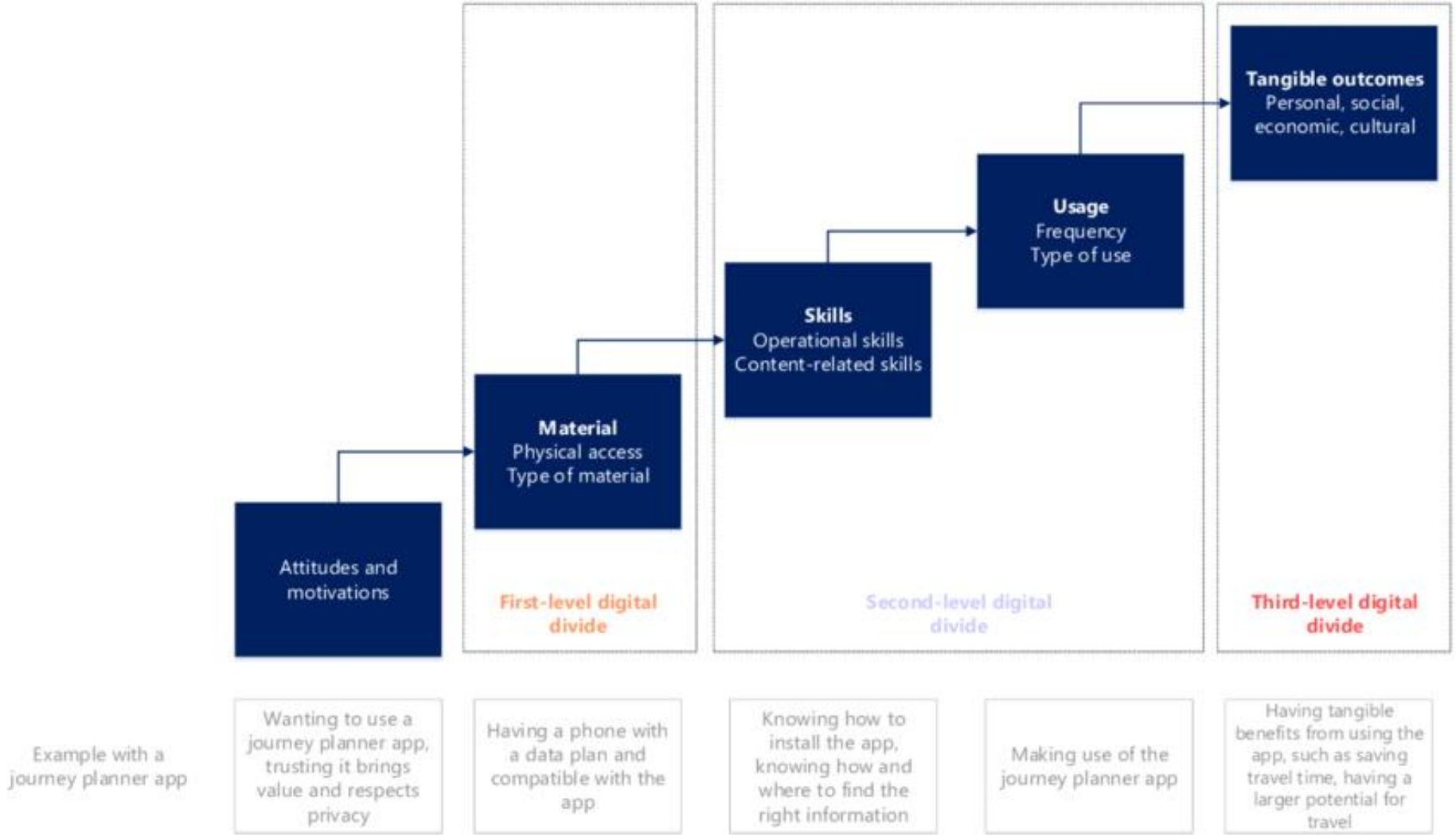
Onderzoeksvraag

Hoe ervaren **Amsterdams minima gezinnen** de alsmaar digitaliserende wereld?

Wat zijn de **barrières en faciliterende factoren** voor volwaardige participatie in de steeds digitaal wordende wereld?

Hoe kan de **digitale toegang** voor gezinnen met een laag inkomen in Amsterdam effectief worden verbeterd?

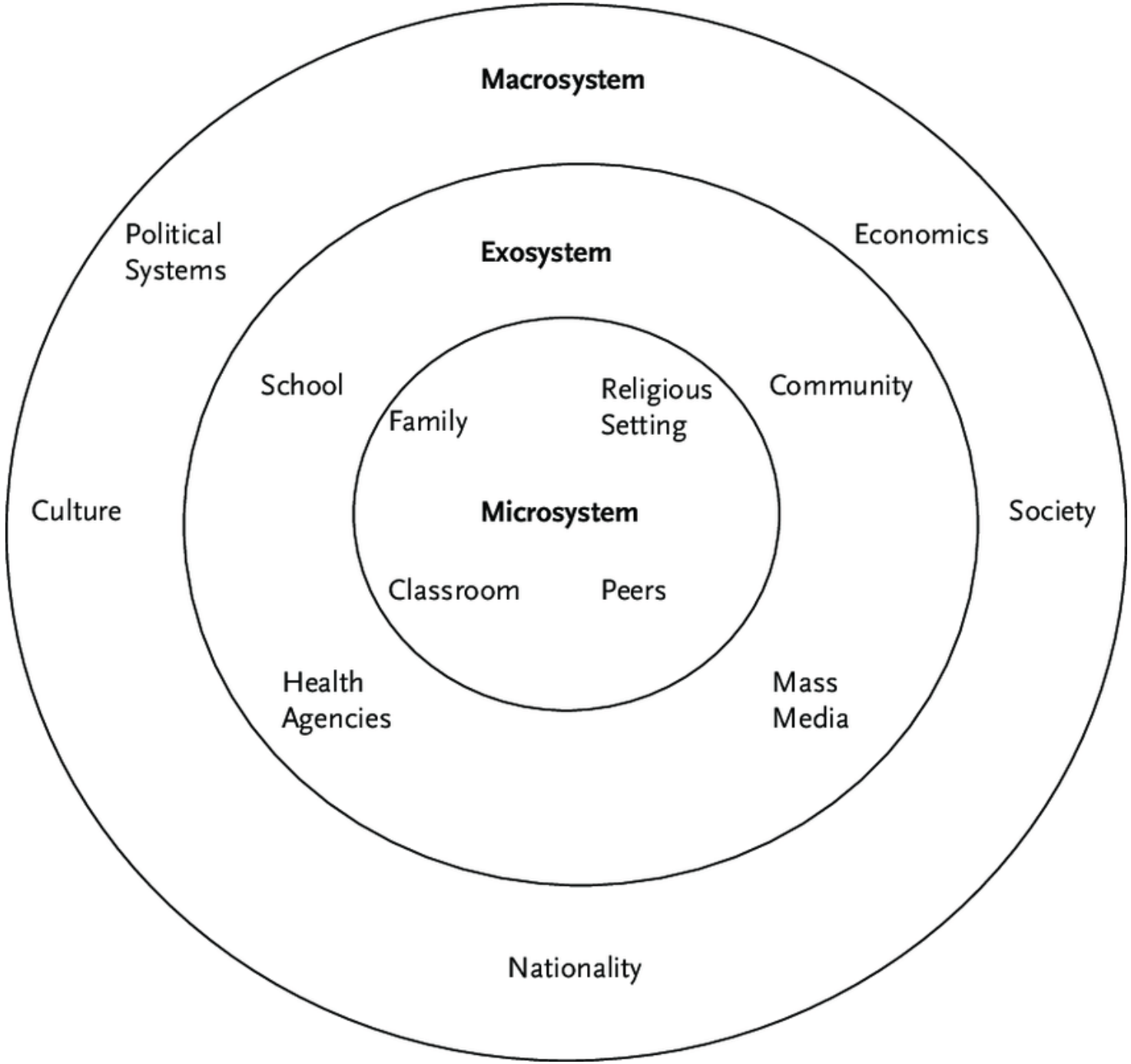
Conceptueel model



Van Dijk, 2005, 2020

Enkele veelgebruikte modellen binnen gezondheidswetenschappen

Sociaal-ecologisch model



Positieve gezondheid

MIJN POSITIEVE GEZONDHEID

LICHAAMSFUNCTIES

- je gezond voelen
- fitheid
- klachten en pijn
- slapen
- eten
- conditie
- bewegen

MENTAAL WELBEVINDEN

- onthouden
- concentreren
- communiceren
- vrolijk zijn
- jezelf accepteren
- omgaan met verandering
- gevoel van controle

ZINGEVING

- zinvol leven
- levenslust
- idealen willen bereiken
- vertrouwen hebben
- accepteren
- dankbaarheid
- blijven leren

KWALITEIT VAN LEVEN

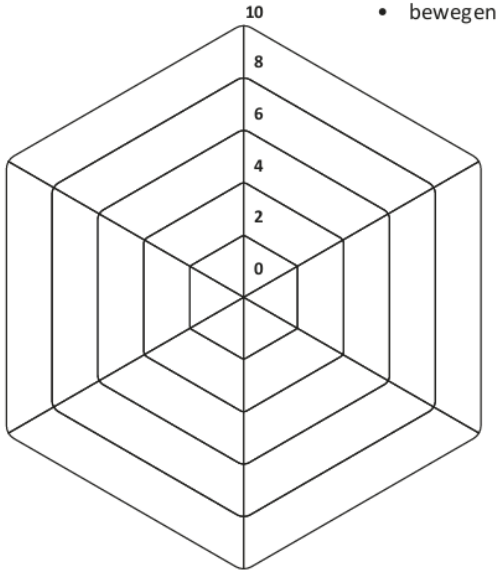
- genieten
- gelukkig zijn
- lekker in je vel zitten
- balans
- je veilig voelen
- hoe je woont
- rondkomen met je geld

MEEDOEN

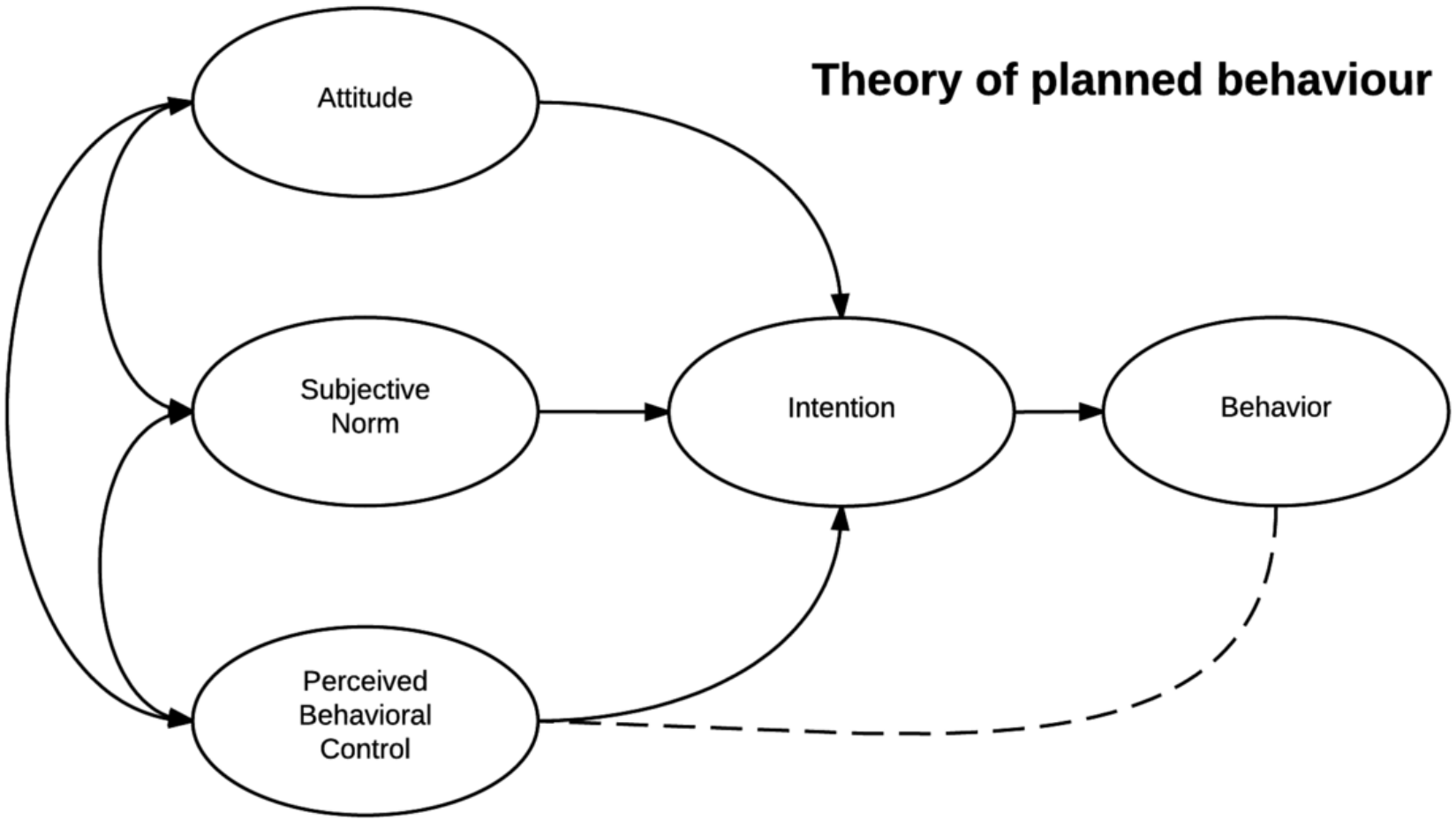
- sociale contacten
- serieus genomen worden
- samen leuke dingen doen
- steun van anderen
- erbij horen
- zinvolle dingen doen
- interesse in de maatschappij

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

- zorgen voor jezelf
- je grenzen kennen
- kennis van gezondheid
- omgaan met tijd
- omgaan met geld
- kunnen werken
- hulp kunnen vragen

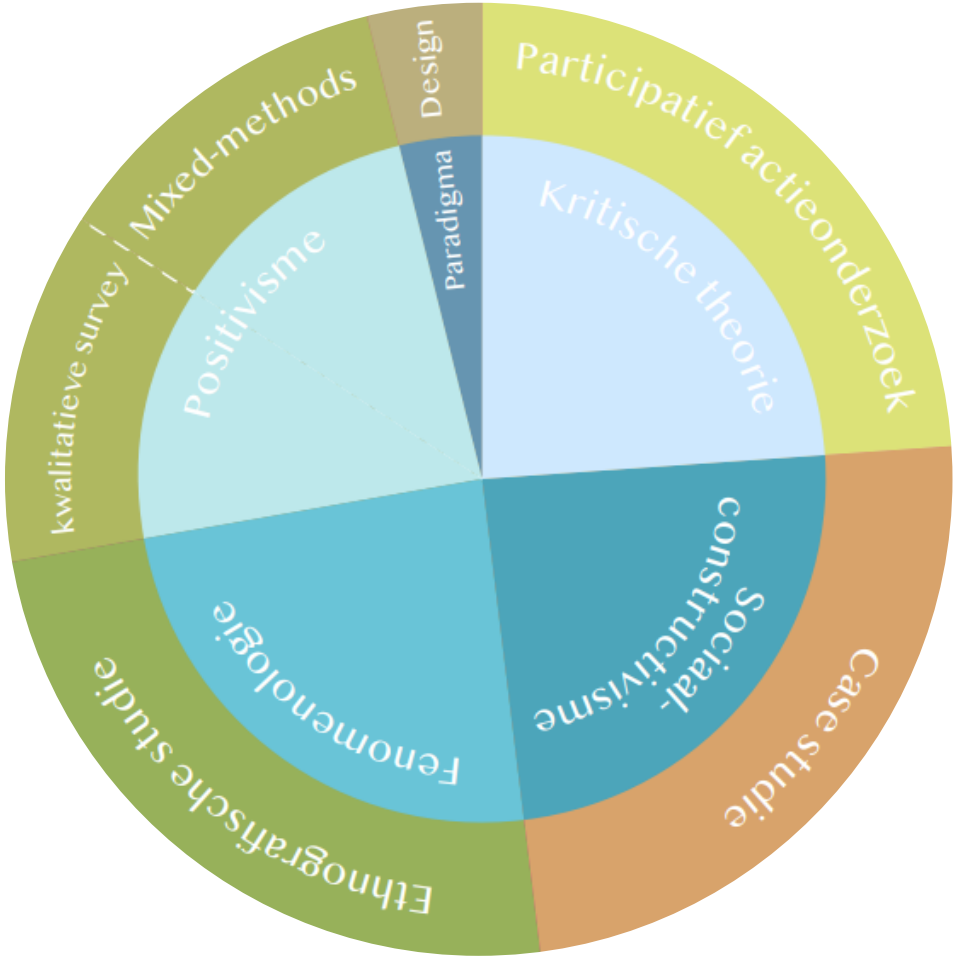


Theory of planned behavior



Probleemstelling

Situering van het onderzoeksdomein
Maatschappelijke en/of wetenschappelijke verantwoording
Het onderzoeksdoel
Onderzoeksvraag
Het conceptueel kader



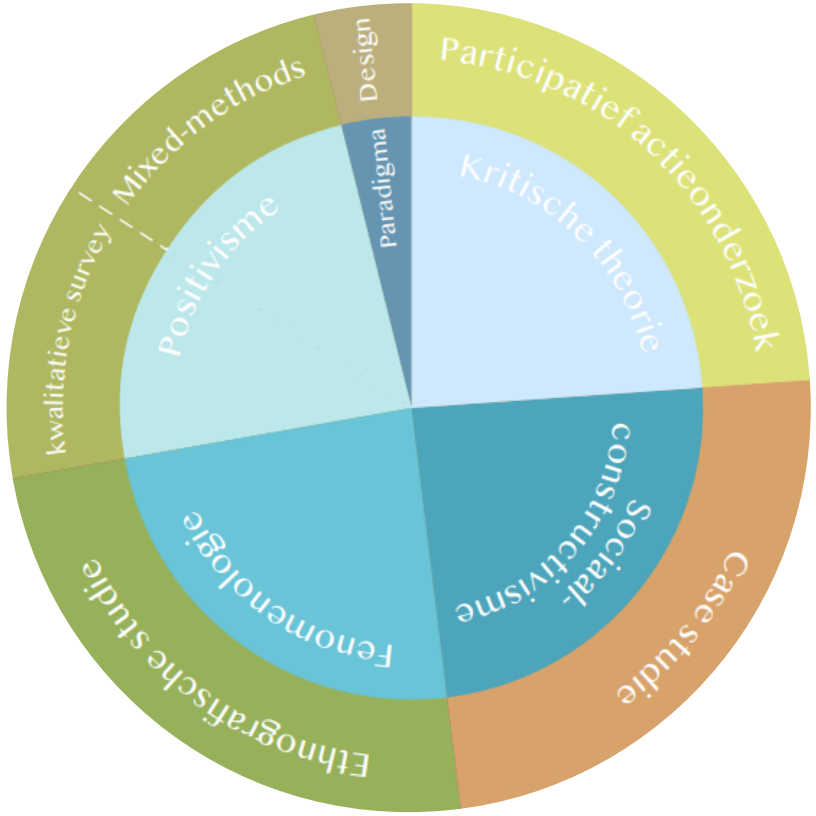
zie: hfdst. 4.2 Mortelmans

Designs

“We used qualitative methods to …”

“This study follows a qualitative study design.”

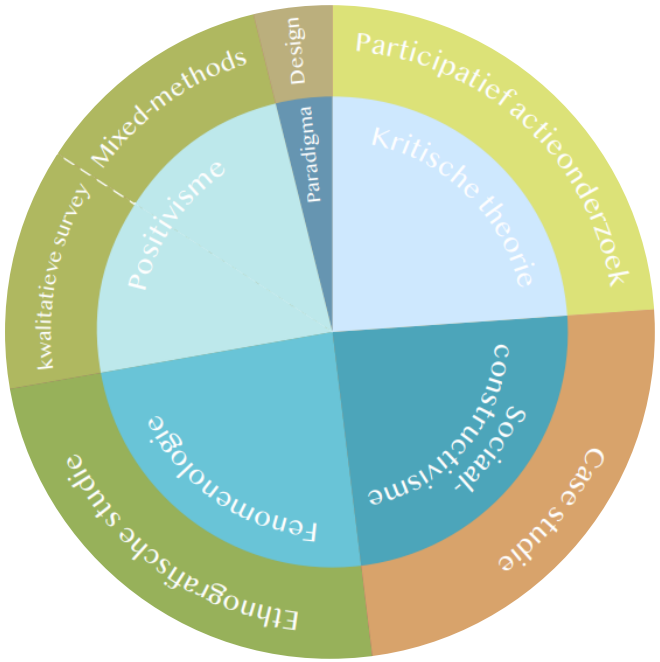
“We conducted a qualitative study into the experiences of…”



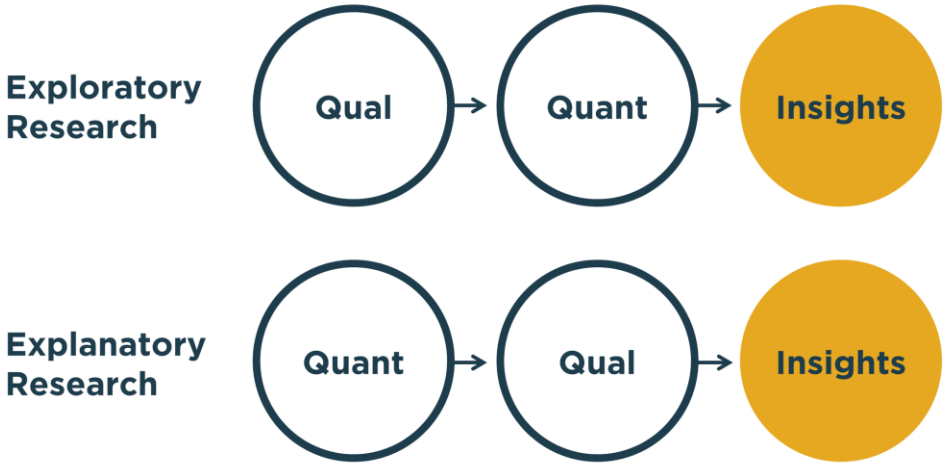
- Designs zijn (op het eerste gezicht) niet zo eenduidig als in kwantitatief onderzoek
- Termen kunnen verschillen per vakgebied (medische antropologie / geneeskunde)

Designs

1. Mixed-methods (12.1)
2. De kwalitatieve survey (4.8.1)
3. Case studie (4.8.3)
4. Ethnografische studie (4.8.2)
5. Participatief Actieonderzoek (HC 8 - Karijn Aussems)



Mixed methods



- Onderzoekobject: divers
- Kennis: exploratief, verklarend
- Methoden: combinatie van kwantitatief en kwalitatief
- Doel: dieper begrip en bevestiging

Mixed methods research is the type of research in which researcher or team of researchers combines elements of qualitative and quantitatve research approaches […] for the purposes of breadth and depth of understanding and corroboration. (Johnson et al., 2007:123)

Kwalitatieve survey

- Onderzoeksobject: individuen
- Type vragen: betekenisvragen
- Kennis over: geleefde ervaring met een fenomeen vanuit perspectief individu
- Tijd: kortdurend/longitudinaal
- Doel: praktijkgericht en/of theorievorming (Grounded Theory)
- Kennis van perspectief doelgroep is daarvoor noodzakelijk
- Methoden: Interviews en/of Focusgroepen

Kwalitatieve survey

The aim is to unravel the (conceptual) assumptions and practices of designers and other professionals responsible for the implementation of patient portals and ePHRs in the Netherlands in order to see how these assumptions and drivers may reproduce, strengthen, or otherwise reconfigure the dynamics of inclusion and exclusion of citizens living in vulnerable circumstances in design practices.

Journal of the American Medical Informatics Association, 28(2), 2021, 276–283
doi: 10.1093/jamia/ocaa273
Advance Access Publication Date: 19 January 2021
Research and Applications

Research and Applications

Persistent inequitable design and implementation of patient portals for users at the margins

Nicole S. Goedhart,[1] Teun Zuiderent-Jerak,[1] Joey Woudstra,[1] Jacqueline E. W. Broerse,[1] Afke Wieke Betten,[2] and Christine Dedding[3]

[1]Athena Institute, Faculty of Science, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Netherlands, [2]Institute for Science in Society, Radboud Universiteit, Nijmegen, Netherlands and [3]Department of Ethics, Law, and Humanities, Amsterdam UMC - location VUmc, Amsterdam, Netherlands

Corresponding Author: Nicole S. Goedhart, Athena Institute, Faculty of Science, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, Netherlands (n.s.goedhart@amsterdamumc.nl)

Received 28 February 2020; Accepted 29 October 2020

ABSTRACT

Objective: Diane Forsythe and other feminist scholars have long shown how system builders' tacit assumptions lead to the systematic erasure of certain users from the design process. In spite of this phenomena being known in the health informatics literature for decades, recent research shows how patient portals and electronic patients health records continue to reproduce health inequalities in Western societies. To better understand this discrepancy between scholarly awareness of such inequities and mainstream design, this study unravels the (conceptual) assumptions and practices of designers and others responsible for portal implementation in the Netherlands and how citizens living in vulnerable circumstances are included in this process.

Materials and methods: We conducted semistructured interviews (n = 24) and questionnaires (n = 14) with portal designers, health professionals, and policy advisors.

Results: In daily design practices, equity is seen as an "end-of-the-pipeline" concern. Respondents identify health care professionals rather than patients as their main users. If patients are included in the design, this generally entails patients in privileged positions. The needs of citizens living in vulnerable circumstances are not prioritized in design processes. Developers legitimize their focus with reference to the innovation-theoretical approach of the Diffusion of Innovations.

Discussion and conclusion: Although feminist scholars have developed important understandings of the exclusion of citizens living in vulnerable circumstances from portal design, other academic efforts have profoundly shaped daily practices of portal development. Diane Forsythe would likely have taken up this discrepancy as a challenge by finding ways to translate these insights into mainstream systems design.

Key words: Patient portals, minority group, inequitable design, feminism, patient engagement

Downloaded from https://academic.oup.com/jamia/article/28/2/276/6104358 by vrije universiteit, Bibliotheek user on 12 January 2025

Ethnografische studie

- Onderzoeksobject: ‘setting’
- Type vragen: beschrijvende vragen
- Doel: Inzicht verschaffen in de ‘cultuur’ van een bepaalde groep of plek
- Kennis over: Sociale context waarin ervaringen betekenis krijgen (waarden en normen, taal, interacties)
- Tijd: vaak langdurige betrokkenheid
- Methoden: Participerende observaties (covert/ overt) & informele gesprekken
- Vaak ook in combinatie met interviews, document onderzoek, fotografie, dialoog

Etnografische studie

INTERNSHIP REPORT

Digital Skills: A Mark of a Good Nurse?

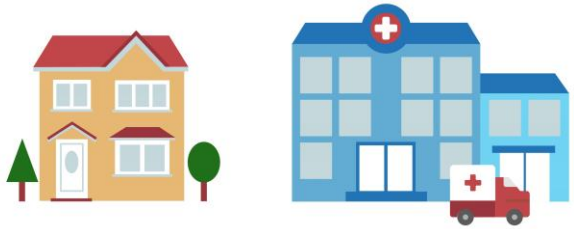
The perspective and needs from nurses, medical assistant and supportive personnel at the Amsterdam UMC regarding the digitalisation of healthcare.

A qualitative study

Titia Bal

STUDENT NUMBER	COMMISSIONING PARTY	ECTS + COURSE CODE SPECIALIZATION
2832347	Amsterdam UMC	27 ECTS + AM_1120
DATE	VU SUPERVISOR	
12 July 2024	Dr. Ramin Kawous	

Case studie



- Onderzoekobject: ‘voorval’ of “phenomenon’
- Grens tussen ‘voorval’ en ‘setting’ is diffuus
- Kennis: begrijpen van het voorval vanuit verschillende perspectieven
- Biedt kans om diepgravende analyses te maken van setting of fenomeen
- Triangulatie van methoden: o.a. interviews, observatie, dialoog, documentanalyse
- Doel: Illustratief, diepgaand met groot leereffect

Case studie

The purpose of this study was to reflect on the implementation of these self-check-in kiosks in a Dutch university hospital, particularly in relation to access to care for more vulnerable patients and intended efficiency goals.

Media and Communication
2024 • Volume 12 • Article 8116
https://doi.org/10.17645/mac.8116

cogitatio

ARTICLE

Open Access Journal

Digitalizing Access to Care: How Self-Check-In Kiosks Shape Access to Care and Efficiency of Hospital Services

Ibrahim Loukili [1], Nicole S. Goedhart [1], Teun Zuiderent-Jerak [2], and Christine Dedding [1]

[1] Department of Ethics, Law and Medical Humanities, Amsterdam University Medical Center, The Netherlands
[2] Athena Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

Correspondence: Ibrahim Loukili (i.loukili@amsterdamumc.nl)

Submitted: 26 January 2024 **Accepted:** 24 April 2024 **Published:** 24 June 2024

Issue: This article is part of the issue "Practices of Digital In- and Exclusion in Everyday Life" edited by Marcel Broersma (University of Groningen), Joëlle Swart (University of Groningen), Denise Mensonides (University of Groningen), Alex Smit (University of Groningen), and Maud Rebergen (University of Groningen), fully open access at https://doi.org/10.17645/mac.i446

Abstract

Responding to labor shortages and rising healthcare expenses, hospitals increasingly turn to self-check-in kiosks to streamline service delivery and improve patients' experiences. The purpose of this study was to reflect on the implementation of these self-check-in kiosks in a Dutch university hospital, particularly in relation to access to care for more vulnerable patients and intended efficiency goals. We followed a technology-in-practice approach to better understand how new technologies shape care practices in relation to in/exclusion and carried out an ethnographic action study involving desk research, participatory observations, semi-structured interviews, and reflection sessions with developers and hospital staff. Data were analyzed through ethnographic content analysis. Our results show that although self-check-in kiosks work well for some patients, many people experience practical and psychosocial difficulties, especially those who go through a complex care pathway, are low-literate, experience a distance the online world, or have sensory, motor, or cognitive impairments. Kiosks are not yet attuned to these patients and typically leave little flexibility and room for negotiation and personal support in what is, for many, a foreign environment. Therefore, patients frequently seek confirmation and assistance from already downsized or busy staff. In conclusion, we find that digitalization under the banner of efficiency within a healthcare system already under pressure carries risks, as it can unintentionally generate extra (invisible) work for patients and care professionals and threaten access to and quality of care for patients most in need. A more concentrated effort on refining the digitalization of healthcare processes using an inclusive-technology-in-practice approach has the potential to contribute to fairer and more efficient care for all patients.

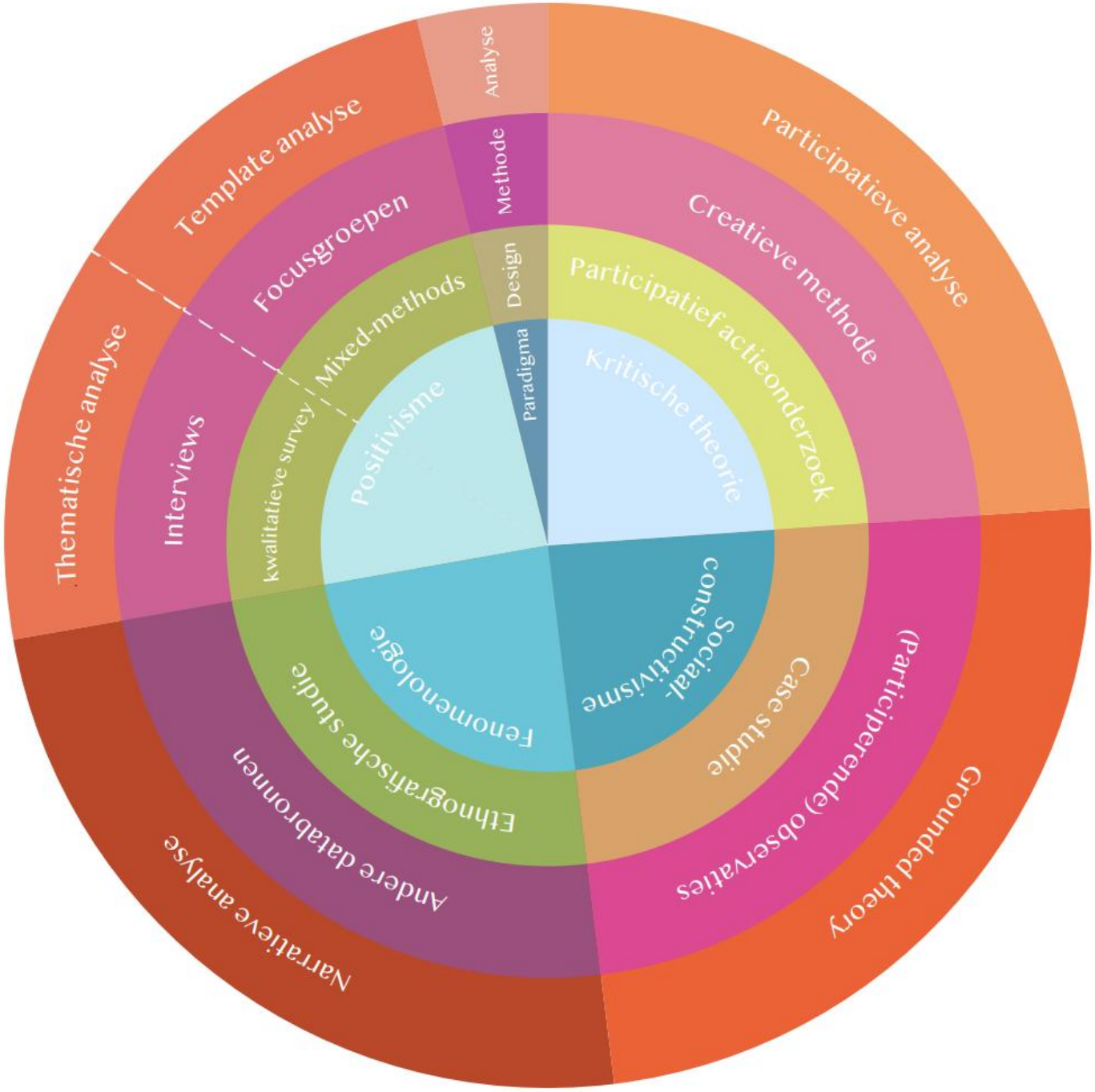
Keywords

access to care; efficiency; eHealth; health inequalities; hospital ethnography; self-check-in kiosks

© 2024 by the author(s), licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY).

Recap

Paradigma (HC2)

Probleemstelling (HC3)

Design (HC3)